

CAPÍTULO 14.32

Artritis Reactiva

PERFIL EUNACOM 1.04.1.010

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Artritis Reactiva** es una inflamación articular aséptica que surge como respuesta inmunitaria a una infección previa en otra parte del organismo, generalmente en el tracto gastrointestinal o genitourinario. Históricamente, cuando se presenta la tríada clásica de artritis, conjuntivitis y uretritis, se denominaba **Síndrome de Reiter**, aunque actualmente se prefiere el término Artritis Reactiva con manifestaciones extraarticulares.

Definición y Temporalidad

La artritis reactiva forma parte del grupo de las **Espondiloartropatías** seronegativas. Su característica principal es que ocurre tras un periodo de latencia de **1 a 4 semanas** después de la infección desencadenante.

- **Curso clínico:** Es una enfermedad que puede ser prolongada.
- **Pronóstico:** A los 6 meses, aproximadamente el 50% de los pacientes se ha recuperado. Al año, la gran mayoría está libre de síntomas, aunque un pequeño porcentaje puede cronificarse.
- **Impacto:** Puede generar una discapacidad funcional significativa durante los meses que dura el cuadro activo.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: A diferencia de la **Artritis Séptica**, en la artritis reactiva **no se encuentran microorganismos viables** dentro de la articulación. Es una respuesta inflamatoria mediada por el sistema inmune (asociada frecuentemente al antígeno **HLA-B27**) ante antígenos bacterianos que persistieron tras la infección inicial.

Manifestaciones Clínicas

Compromiso Articular

Es la manifestación cardinal y suele presentarse de dos formas: 1. **Oligoartritis asimétrica:** Afecta a pocas articulaciones (habitualmente menos de 4), involucrando tanto pequeñas como grandes articulaciones, con predilección por los miembros inferiores (rodillas, tobillos). 2. **Monoartritis:** No es infrecuente. Aunque suele ser menos explosiva que una infección purulenta, siempre plantea el desafío diagnóstico de descartar una causa infecciosa directa.

El Síndrome de Reiter (Manifestaciones Extraarticulares)

Se define clásicamente por la tríada: **Artritis + Conjuntivitis + Uretritis**.

- **Compromiso Ocular:**
 - **Conjuntivitis:** Suele ser bilateral, leve y transitoria.
 - **Uveítis** anterior: Ojo rojo profundo y doloroso, similar a otras espondiloartropatías.
- **Compromiso Genitourinario:**
 - **Uretritis:** Puede ser la causa (infección por Chlamydia) o parte de la reacción autoinmune (estéril).
 - **Balanitis Circinada:** Lesiones cutáneas en el glande, caracterizadas por placas serpiginosas con bordes bien definidos. **No es una ETS**, sino una manifestación inmunológica.
 - Úlceras genitales.
- **Otras manifestaciones:**
 - Úlceras orales indoloras.
 - **Entesitis:** Inflamación en los sitios de inserción de tendones y ligamentos (típicamente el tendón de Aquiles o la fascia plantar).
 - Dactilitis (dedos en salchicha).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia clásica (en inglés): "*Can't see, can't pee, can't climb a tree*" (No puede ver -conjuntivitis-, no puede orinar -uretritis-, no puede trepar un árbol -artritis-).

Etiología: Agentes Desencadenantes

Los patógenos asociados a la artritis reactiva son principalmente bacterias gramnegativas intracelulares o enterobacterias.

TABLA 14.32.1: ORIGEN DE LA INFECCIÓN VS AGENTES ETIOLÓGICOS PRINCIPALES

ORIGEN DE LA INFECCIÓN	AGENTES ETIOLÓGICOS PRINCIPALES
Gastrointestinal (Entérico)	<i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Yersinia</i> .
Genitourinario	<i>Chlamydia trachomatis</i> .
Otros	<i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Clostridioides difficile</i> .

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante una **uretritis** en el contexto de una artritis reactiva, es obligatorio descartar una infección activa por *Chlamydia trachomatis*. Si se confirma, debe tratarse inmediatamente con **Doxiciclina** o **Azitromicina** para erradicar el foco infeccioso, aunque esto no siempre detenga la progresión de la artritis ya desencadenada.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**, basado en la historia de una infección previa compatible y el patrón de compromiso articular.

- **Anamnesis:** Buscar antecedentes de diarrea o sospecha de ETS en el mes previo.
- **Examen físico:** Buscar signos de entesitis, balanitis, úlceras orales o compromiso ocular.
- **Laboratorio:**
 - El **HLA-B27** no es diagnóstico por sí solo, pero apoya la sospecha clínica (especialmente en casos de compromiso axial o recurrencias).
 - Reactantes de fase aguda (VHS, PCR) suelen estar elevados.
- **Estudio de Líquido Sinovial:** Es mandatorio realizar una **punción articular** ante una monoartritis para descartar **Artritis Séptica** o gota. En la artritis reactiva, el líquido será inflamatorio pero con cultivos negativos (estéril).

Tratamiento

A diferencia de otras enfermedades reumatológicas crónicas, el enfoque aquí busca controlar la inflamación aguda mientras el cuadro autolimitado resuelve.

- **Primera Línea (AINES):** Son la base del tratamiento para el manejo del dolor y la inflamación articular. Se utilizan a dosis plenas (ej. Indometacina, Naproxeno).
- **Segunda Línea (Corticoides):**
 - Si no hay respuesta a AINES o el compromiso es muy invalidante.
 - Pueden usarse por vía **oral** o mediante **infiltración intraarticular** (esta última es muy útil en monoartritis persistentes).
 - Tienen una respuesta más rápida que en otras espondiloartropatías.
- **Antibióticos:** Solo están indicados si existe evidencia de una infección activa (ej. uretritis por Chlamydia). No se ha demostrado que el tratamiento antibiótico prolongado trate la artritis en sí.

- **Fármacos Modificadores de la Enfermedad (FAME):** En casos que se vuelven crónicos (más de 3-6 meses), se puede considerar el uso de Sulfasalazina o Metotrexato. Los biológicos (anti-TNF) se reservan para casos refractarios muy severos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que la **Artritis Reactiva** es una de las causas más frecuentes de oligoartritis en adultos jóvenes. Siempre que veas un caso de artritis después de una diarrea o una conducta sexual de riesgo, piensa en este diagnóstico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 30 años con monoartritis de rodilla 3 semanas después de una gastroenteritis por Salmonella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Reactiva. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Artritis que aparece 1-4 semanas post-infección; puede durar meses (50% recuperado a los 6 meses)
- Síndrome de Reiter: artritis reactiva + compromiso ocular (conjuntivitis/uveítis) + compromiso genital (uretritis/balanitis circinada)
- Diferenciar uretritis infecciosa por Chlamydia (tratar con doxiciclina) de uretritis reactiva autoinmune
- Agentes: Chlamydia, Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Shigella, C. difficile
- Tratamiento: AINEs (primera línea) + corticoides (segunda línea, a diferencia de otras PEA donde son biológicos)
- HLA-B27 apoya el diagnóstico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS REACTIVA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 30 años con monoartritis de rodilla 3 semanas después de una gastroenteritis por Salmonella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Artritis séptica
- B) Gota
- C) Artritis reactiva
- D) Artritis reumatoide
- E) Artrosis

PREGUNTA 2

Paciente con artritis reactiva y uretritis. ¿Qué debe descartarse antes de atribuir la uretritis al cuadro reactivo?

- A) Infección por E. coli
- B) Infección por Chlamydia trachomatis
- C) Infección por VIH
- D) Infección por gonococo
- E) Cistitis intersticial

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de segunda línea en artritis reactiva que no responde a AINEs?

- A) Fármacos biológicos (anti-TNF)
- B) Metotrexato
- C) Corticoides (oral o intraarticular)
- D) Ciclofosfamida
- E) Rituximab

RESUMEN: ARTRITIS REACTIVA

La artritis reactiva es una pelvispondiloartropatía que ocurre 1-4 semanas después de una infección. Se presenta como oligoartritis asimétrica o monoartritis (no tan inflamatoria como la séptica, pero hay que descartarla). Puede durar varios meses: a los 6 meses la mitad se ha recuperado, al año la mayoría. El síndrome de Reiter es la variante con síntomas extraarticulares: compromiso ocular (conjuntivitis, uveítis) y compromiso genital (uretritis, úlceras genitales, balanitis circinada). Es importante diferenciar la uretritis por clamidia (infecciosa, tratar con doxiciclina/azitromicina) de la uretritis autoinmune reactiva. Los agentes etiológicos más frecuentes son: *Chlamydia* (*trachomatis* y *pneumoniae*), *Campylobacter*, *Yersinia*, *Salmonella*, *Shigella* y *Clostridioides difficile*. El diagnóstico es clínico (infección previa + artritis clásica descartando otra causa). El HLA-B27 apoya el diagnóstico. El tratamiento es con AINEs (primera línea) y corticoides (oral o intraarticular) de segunda línea, a diferencia del resto de pelvispondiloartropatías donde la segunda línea son biológicos.